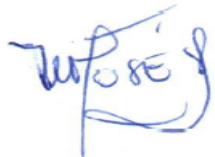


	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 1 de 12

PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
E.U. María José Solís L	Klgo. Abraham Muñoz V	Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Coordinadora SUR	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Dr. Orlando Leyton A
Fecha: 04-05-2026	Fecha: 05-05-2026	Fecha: 08-05-2026
Firma:	Firma:	Firma:
		

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 2 de 12

I. INTRODUCCIÓN.

Existen una serie de patologías que requieren manejo a nivel secundario y terciario, las cuales son detectadas en los Centros de Salud Familiar y Servicios de Urgencias Rurales y que deben ser derivados bajo un sistema que asegure principios básicos de seguridad a los usuarios en su traslado. El presente protocolo establece tales principios junto a los tipos de transporte e información que acompaña al usuario/a ante una derivación.

II. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL

Velar por la seguridad de los usuarios mediante un procedimiento documentado en el que se describe la continuidad de la atención en los casos diagnosticados que exceden la capacidad de resolución del CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Servicio de Urgencia Rural.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estandarizar el traslado para proveer atención a los usuarios del CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Servicio de Urgencia Rural (SUR) Peralillo, que sean derivados a Hospital de referencia.
- Definir las condiciones del transporte en el traslado.
- Definir el tipo de información que debe acompañar al usuario/a.

III. PROPÓSITO

La finalidad de este protocolo es disponer de un sistema de traslado de los usuarios que presentan urgencias que exceden la capacidad de resolución

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 3 de 12

desde el Servicio de Urgencia Rural (SUR) y CESFAM Dr. Orlando Leyton A. hacia Servicio de Urgencia de Hospital de base microárea.

IV. ALCANCE

Dirigido a todos los funcionarios que participen en el procedimiento de traslado de usuarios hacia los dispositivos de urgencia regionales.

V. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Profesionales Médicos, Cirujanos Dentistas y Matronas

- Profesionales responsables de decidir y activar el proceso de derivación y traslado de usuario.
- Realizar documentos de emisión de interconsulta.
- Dar aviso al centro hospitalario para que éste se autorice y se preparen para la recepción del usuario y/o solicitar ambulancia SAMU, según necesidad.
- Entregar la documentación requerida al TENS para derivación.

TENS de Traslado de Urgencia

- Acompañar y asistir al usuario durante el traslado.
- Mantener la seguridad del equipamiento y el usuario durante el traslado.
- Llevar consigo documentos antes mencionados del usuario a Hospital de Base.

Conductores:

- Conducir con seguridad durante el traslado según la normativa de tránsito vigente.
- Apoyar al TENS de traslado con la activación de los mecanismos de seguridad para el paciente.

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 4 de 12

VI. DEFINICIONES.

Emergencia: Condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo vital y/o riesgo de secuela funcional grave para una persona, de no mediar atención médica inmediata e impostergable.

Urgencia: Aparición fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia”. Una Urgencia es una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte, pero se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo según la condición para evitar complicaciones mayores.

SUR: Servicio de Urgencia Rural.

Traslado: Es el que se realiza desde un Centro de Salud a otro.

AEB: Ambulancia de Emergencia Básica.

AEA: Ambulancia de Emergencia Avanzada.

DAU: Dato de Atención de Urgencias, documento legal, en el cual se mantiene registro de todas las prestaciones otorgadas, los insumos utilizados, las indicaciones al alta y el estado del usuario.

Interconsulta: Documento que se realiza para el traslado de un usuario derivado a un centro de mayor complejidad.

Módulo asistencial: Corresponde a la zona posterior de una ambulancia, donde va la camilla con el usuario afectado.

Cabina: Corresponde al área de la ambulancia donde va el conductor.

SAMU: Servicio de Atención Médico de Urgencias, institución dependiente del Ministerio de Salud, cuya labor es entregar atención prehospitalaria en situaciones de urgencia y emergencia. Es monitoreado por un centro regulador a cargo de un médico cirujano que analiza, evalúa y aconseja en las llamadas de urgencia de toda la población.

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 5 de 12

VII. DESARROLLO DEL PROCESO

1. Responsable que decide la derivación.

Médicos, Cirujanos Dentistas, Matronas a cargo de la atención.

2. Procedimiento de derivación.

- Una vez evaluado el usuario y establecida la necesidad resolutive externa, el profesional a cargo de la atención, procederá a llenar el **formulario de solicitud de interconsulta el cual podrá ser digital o escrito** (Anexo 1).
- El traslado del usuario deberá ser efectuado en una ambulancia, siempre en compañía de un TENS, quien se encargará de entregar documentos en el establecimiento de destino.
- En aquellos casos en los cuales el usuario se niegue a ser derivado y trasladado, se utilizarán los siguientes criterios:
 - a) **Solicitud Expresa:** El paciente, representante legal o tutor debe solicitar el alta.
 - b) **Información de Riesgos:** El profesional tratante tiene la obligación de informar claramente los riesgos, consecuencias y posibles complicaciones al no ser derivado. Deberá dejar esto enunciado en el DAU.
 - c) **Firma de Documento:** Se debe firmar el DAU, donde el paciente asume la responsabilidad de la decisión y exonera de responsabilidad al SUR.
 - d) **Capacidad del Paciente:** El paciente debe estar en condiciones de comprender la información. Se recomienda que en caso que existan acompañantes, esté presente ante tal situación.
 - e) **Registro en Ficha Clínica:** Se debe dejar constancia detallada en el DAU, incluyendo la evolución médica y el procedimiento administrativo realizado.

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 6 de 12

3. Tipo y condiciones de traslado dependiendo de la gravedad y requerimientos clínicos del usuario.

Puede llevarse a cabo el traslado de las siguientes formas según la evaluación del profesional tratante:

- **Traslado en AEB de la institución** la cual cuenta con equipamiento consistente como mínimo en: motor de aspiración, red de oxígeno, equipo para control de signos vitales e insumos necesarios para la estabilización hemodinámica del usuario, sin encontrarse en riesgo vital.

El traslado es efectuado por un conductor acompañado de un TENS.

El TENS irá ubicado en el módulo asistencial, en la butaca situada en el costado de la camilla. Esta ubicación permitirá monitorear al paciente y tener acceso directo a los dispositivos médicos. Deberá, cuando le sea posible, estar asegurado con cinturón de seguridad.

Durante el traslado deberá mantener las puertas traseras cerradas y verificar el correcto anclamiento de monitores, camillas, oxígenos.

El usuario que va en la camilla antes de ser subido a la ambulancia deberá contar con los siguientes sistemas de seguridad activos:

- Barandas de camilla en alto.
- Cinturones de camillas (correas) amarradas.

Se permite un acompañante de la persona afectada en ambulancia la cual irá de preferencia en la cabina al lado del conductor. Sin embargo, el acompañante podrá ir en el módulo asistencial en los siguientes casos: Cuando la persona afectada sea menor de edad, personas mayores, dependientes severos o personas incapacitadas para comunicarse (daño neurológico/conciencia), personas con discapacidad u otro caso solicitado por el equipo clínico.

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 7 de 12

▪ **Traslado en AEB o AEA de SAMU:** la cual cuenta con equipamiento especializado consistente en: motor de aspiración, red de oxígeno, equipo para control de signos vitales y elementos necesarios para apoyar un procedimiento de reanimación cardiopulmonar avanzada, elementos de manejo avanzado de la vía aérea, acceso vascular, soporte farmacológico, monitorización y/o desfibrilación.

El médico derivador realiza llamado a centro regulador SAMU, y médico regulador de la entidad, determina el móvil que realiza el traslado; basándose en la condición clínica y gravedad del usuario. En este caso, el responsable de la entrega del usuario y su información clínica al centro receptor, es el profesional reanimador del equipo SAMU.

4. Información que debe acompañar al usuario.

El personal encargado del traslado al usuario debe portar:

- En el caso de traslados derivados por Cirujanos Dentistas y Matronas:
 - Hoja de interconsulta, la cual podrá ser de forma digital o escrita. Deberán ser llenados los siguientes campos: Fecha, Nombre del usuario, RUN, establecimiento de destino, diagnóstico, fundamentos diagnósticos, Nombre y firma del profesional que deriva.
 - Cédula de identidad y/o pasaporte del usuario, si la posee.
- En el caso de traslados derivados por urgencias médicas vistas en SUR se deberá anexar el Dato de Urgencia (DAU) de plataforma FONENDO (Anexo 2). Si por problemas de plataforma digital, la Interconsulta no se puede realizar, se debe anexar la hoja de interconsulta y DAU escrito.

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 8 de 12

5. Red de derivación.

Todos los casos de urgencias que excedan la capacidad de resolución de CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Servicio de Urgencia Rural Peralillo serán derivados a Hospital base de microárea correspondiente a Hospital de Santa Cruz.

En el caso de urgencias de carácter médico la derivación será al Servicio de Urgencia de Hospital de Santa Cruz.

En el caso de urgencias dentales la derivación será al Servicio de Urgencia de Hospital de Santa Cruz, previo envío de información al Jefe de CEOM para favorecer enlace interno del Centro Hospitalario.

En el caso de urgencias matrona la derivación será a Servicio de Urgencia Maternal de Hospital Santa Cruz, previo envío de antecedentes a matrona de turno.

En cualquier caso, independiente de informar al profesional de la especialidad del centro derivador, el enlace y coordinación se realizará con el médico de turno del servicio de urgencia hospitalario.

VIII. DISTRIBUCIÓN

- ✓ Equipo SUR
- ✓ Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- ✓ Unidad de Calidad y Seguridad del usuario CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- ✓ Médicos
- ✓ Matronas
- ✓ Cirujanos dentistas.
- ✓ Jefe de Movilización
- ✓ Conductores

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 9 de 12

IX. BIBLIOGRAFÍA

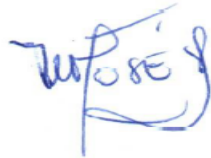
1. Norma Ministerial N° 17, sobre sistema de atención médica de urgencia.
2. www.medynet.com/usuarios/jraguilar/trasladodepacientescriticos.pdf.
3. HOSPITAL Santiago Oriente. Normas de derivación a la Unidad de Emergencia Referida del Hospital Santiago Oriente. [en línea]. Santiago
4. Protocolo Traslado Secundario en la Red Local de Urgencia en el Servicio Salud O'Higgins

X. AUTORES

Christian Rolle, Médico Cirujano, Referente Técnico S.U.R Peralillo.

María José Solís Letelier, Enfermera Universitaria, Referente Administrativo S.U.R Peralillo.

XI. CONTROL DE CAMBIOS

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)
Se agregan funciones al conductor, se especifican partes de la ambulancia. Se define lugar de acompañamiento para el acompañante, se establecen mecanismos de seguridad básicos.	8-5-2026	EU María José Solís. 	Cristian Cárdenas E.  

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 10 de 12

Anexo 1: Formulario de Interconsultas digital y escrito

MINISTERIO DE SALUD S.S. del Libertador B O Higgins Ilustre Municipalidad de Peralillo CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A		SOLICITUD DE INTERCONSULTA O DERIVACIÓN	
--	--	--	--

Fecha Solicitud: Día Mes Año Estado SIC: Nueva

1. Servicio de Salud	2. Establecimiento
S.S. del Libertador B O Higgins	CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A

Apellido Paterno: [REDACTED] Apellido Materno: [REDACTED] Nombres: [REDACTED]

RUN: [REDACTED] Si es recién nacido, RUN de padre o madre beneficiario: [REDACTED] RUN Madre: [REDACTED]

MUJER [REDACTED] 66 años 11 meses 22 días

Sexo: [REDACTED] Fecha de Nacimiento: [REDACTED] Edad: [REDACTED]

Domicilio (calle, número, número interior, bloque (block), villa, localidad): [REDACTED]

Peralillo [REDACTED]

Comuna de residencia	Teléfono	Teléfono 2	Teléfono Movil	Teléfono Laboral	Teléfono Contacto
Correo Electrónico	Juana				

Nombre Padre: [REDACTED] Nombre Madre: [REDACTED]

DATOS CLINICOS
 Se deriva para atención en: Santa Cruz [HAT3]

S.S. del Libertador B O Higgins MEDICINA INTERNA *Ingueis*

Servicio: [REDACTED] Especialidad: [REDACTED]

Se envía a consulta para: REALIZAR TRATAMIENTO Otro -->

Hipótesis diagnóstica o diagnóstico: - (I82) OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS; TVP PIERNA IZQ - Diagnóstico Principal

¿Sospecha problema de salud AUGÉ? NO ☒ SI ☐ Especificar Problema:

Prioridad: Alta *Se entrega caso a M. Bustamanti*

Fundamentos del diagnóstico:

 PX REFIERE AUMENTO DE VOL EN PIERNA IZQ DESDE HACE 7 DIAAS APROX, ACOMPAÑADA DE DOLOR DE MODERADA INTENSIDAD EL CUAL SE INTENSIFICA A LA DEAMBULACION, SIN CAMBIOS DE COLORACION.

 AM: TVP 2015 en EEII izq, HTA, soplo, anemia hemolítica

 AQ: varices en pierna izq.

 Med: Bisoprolol, Espironolactona, Prednisona 20 mg c/8h, Ac. fólico

 Alergias: no

 EXAMEN FISICO

 PIEL Y GENERAL: Pálida, ictérica, afebril, hidratado.

 CABEZA Y CUELLO: Normocefalo, sin adenopatías cervicales ni tumoraciones.

 CARDIOPULMONAR: Tórax simétrico normoexpansible, Murmullo Pulmonar audible en ambos campos pulmonares soplo holosistólico IV/VI hiperdinámico. Ruidos cardiacos rítmicos en 2 tiempos sin soplos.

 ABDOMEN: Blando depresible no doloroso a la palpación superficial ni profunda, ruidos hidroaéreos presentes, sin viceromegalias. Púño percusión negativa.

 NEUROLOGICO: Consciente, orientado en tiempo espacio y persona, sin signos meníngeos, normoreflexico.

 MIEMBROS: pierna izq con edema importante sobre la rodilla con edema q deja fovea, dolor a la palpacion, s. homans +

 Ilene capilar ok



**PROTOCOLO DE TRASLADO DE
USUARIOS QUE EXCEDEN
CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN**

Código:	AOC 2.1
Fecha:	Mayo 2026
Versión:	2.0
Vigencia:	Mayo 2030
Página:	Página 11 de 12

3. Especialidad		4. Unidad	
5. Nombre			
6. Historia Clínica			
7. RUT		8. Si se recibe cargo RUT de padre o madre beneficiario	
9. Sexo (marcar con X)		10. Fecha de Nacimiento	
11. Edad		12. Domicilio (calle, número, nombre interior, bloque (block), villa, localidad)	
13. Comuna de residencia		14. Teléfono 1	
15. Teléfono 2		16. Correo Electrónico	
17. Se deriva para atención en:			
18. Esperanza de vida			
19. Se envía a consultar para:			
20. Historia diagnóstica o diagnósticos (señalar con letra legible y sin abreviar)			
21. ¿Búsqueda activa de salud AUGET?			
22. Subgrupo o subproblemas de salud AUGET (si corresponde)			
23. Fundamentos del Diagnóstico			
24. Exámenes Realizados			
25. Nombre			
26. RUT			
Firma Profesional			

	PROTOCOLO DE TRASLADO DE USUARIOS QUE EXCEDEN CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN	Código:	AOC 2.1
		Fecha:	Mayo 2026
		Versión:	2.0
		Vigencia:	Mayo 2030
		Página:	Página 12 de 12

Anexo 2. Dato de Urgencia.

Datos Atención de Urgencia e Informe de Lesiones Folio: 6058331 **C3**

CESFAM PERALILLO

15:28 Fecha Egreso: 11/01/21 Hora Egreso: 16:59

Nombre Social: [REDACTED] Edad: [REDACTED] Rut: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED] Fecha Nac.: [REDACTED] Sexo: [REDACTED]
Números de Contacto: [REDACTED]

Previsión: FONASA TIPO C Convenio: FONASA
Inscrito en: PERALILLO, CESFAM N° Ficha: 5290

MOTIVO CONSULTA: enviada de policlinico
TIPO ACCIDENTE/SUCESO: Médico
ACOMPAÑANTE:
RELACIÓN: FONO: RUN:

CATEGORIZACIONES

NIVEL	HORA	PROFESIONAL	SINTOMAS	EVOLUCIÓN	GLASGOW
3	15:43 11/01	C. Veas	Malestar en pierna izq	7 días	15

SIGNOS VITALES Peso: 0 Kg.
HORA **FR** **PA** **PAM** **SAT02** **FI02** **FC** **T° AX** **T° REC** **T° OTR** **EVA** **HGT**
15:41 11/01 136/68 91 95 0 36.3 --

GLASGOW [15]

EPOC ☐ CARD ☐
DM ☐ SBO ☐
HTA ☒ GENO ☐
EPI ☐ ASMA ☐

OTRO ☐
ALERGIAS NO
EMBARAZO ☐
P / A / G 11

ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
HIPOTESIS DIAGNÓSTICA
EVOLUCIÓN
DIAGNÓSTICO GES
No se indican diagnósticos GES.
INDICACIONES MÉDICAS
No se registran indicaciones médicas.
INDICACIONES MÉDICAS DE DOMICILIO
No aplica
OTRAS INDICACIONES MÉDICAS DE DOMICILIO
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

Derivados a HSC
Dr. TVP pierna izq

Dra. Mariana Rodríguez Morales
Rut: 26.570.431-3
Médico Cirujano
Esp. en Cirugía General